

UNIVERSITE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE

EXAMEN UNITE D'ENSEIGNEMENT DE PHARMACOLOGIE

Veuillez cocher la ou les propositions justes durée III : 15

1. Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes :

- a. Le foie est le principal organe du métabolisme des médicaments
- b. Tous les médicaments sont inactifs avant d'être métabolisés
- c. Les métabolites des médicaments peuvent parfois être toxiques
- d. La première phase du métabolisme hépatique implique principalement des réactions de conjugaisons
- e. Le métabolisme a pour principal objectif de rendre le médicament plus hydrosoluble pour faciliter son élimination

2. Au sujet de l'induction enzymatique :

- a. Elle augmente l'activité des enzymes de métabolisation
- b. N'a aucun impact sur les interactions médicamenteuses
- c. N'a pas d'impact sur l'effet thérapeutique
- d. Le tabac est un inducteur enzymatique
- e. L'oméprazole est un inducteur enzymatique

3. Concernant l'élimination des médicaments :

- a. La sécrétion tubulaire des médicaments est un phénomène actif qui utilise des transporteurs
- b. Les substances transportées par un même système peuvent entrer en compétition
- c. L'alcalinisation des urines favorise l'élimination des bases faibles
- d. L'insuffisance rénale n'a pas d'impact sur l'élimination des médicaments
- e. Le cycle entérohépatique raccourcit la durée d'activité des médicaments

4. Concernant les médicaments du système parasympathique :

- a. L'atropine est indiquée dans la maladie d'alzheimer
- b. La nicotine est indiquée dans le traitement du glaucome
- c. La néostigmine est indiquée dans le traitement de la myasthénie
- d. La scopolamine est indiquée comme antinauséeux dans le mal des transports
- e. L'ipatropium est indiqué comme bronchodilatateur dans le traitement de l'asthme

5. Les parasympatholytiques de synthèse peuvent être utilisés dans le traitement de :

- a. La constipation
- b. La maladie de parkinson
- c. La dépression
- d. L'anxiété
- e. L'asthme

6. Les acétylcholinestérasiques agissent par :

- a. Blocage du récepteur muscarinique de l'acétylcholine
- b. Blocage du récepteur nicotinique de l'acétylcholine
- c. Inhibition de l'acétylcholinestérase
- d. Augmentation de la libération de l'acétylcholine
- e. Diminution de la dégradation de l'acétylcholine

7. Concernant les myorelaxants :

- a. Agissent sur le récepteur muscarinique de l'acétylcholine
- b. Les benzodiazépines sont des myorelaxants à action centrale
- c. Les doses myorelaxantes des benzodiazépines sont moins élevées que les doses anxiolytiques
- d. Le baclofène est indiqué dans les blépharospasmes
- e. Le dantrolène est utilisé en cas d'hyperthermie maligne et dans le syndrome malin des neuroleptiques.

8. Lesquels des médicaments suivants sont des curarissants non dépolarisants :

- a. Succinylcholine
- b. Pancuronium
- c. Tubocurarine
- d. L'Acétylcholine
- e. Diazépam

9. Les curares entraînent :

- a. Une paralysie dans l'ordre des gros muscles, puis des petits muscles
- b. Une perte de la conscience
- c. Une hypertension
- d. Une augmentation de la pression intragastrique via la succinylcholine
- e. Des fasciculations transitoires au niveau du thorax et de l'abdomen via la succinylcholine

10. Un effet indésirable est :

- a. Une réaction nocive, voulue, qui se produit uniquement en cas de surdosage
- b. Une réaction nocive, voulue, qui se produit aux posologies thérapeutiques
- c. Une réaction nocive, non voulue, qui se produit aux posologies thérapeutiques
- d. Observé en cas d'une utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament
- e. Une réaction liée à l'utilisation d'un médicament défectueux ou de mauvaise qualité

11. Les effets indésirables médicamenteux de type A

- a. Sont directement liés à l'effet principal du médicament
- b. Sont uniquement d'ordre pharmacocinétique
- c. Sont assez fréquents, et connus dès les essais cliniques
- d. Peuvent être d'origine immunologique
- e. Se produisent suite à une prise chronique du médicament

12. Les caractéristiques des réactions pseudo-anaphylactiques sont les suivantes

- a. Réaction immuno-allergique
- b. Réaction non immuno-allergique
- c. Nécessite la liaison antigène-anticorps
- d. Sont dues à la libération directe d'histamine secondaire à la dégranulation des basophiles
- e. Elles nécessitent une sensibilisation préalable

13. Les éléments à déclarer dans un système de pharmacovigilance lié aux médicaments sont :

- a. Les molécules d'homéopathie
- b. Les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une ATU (autorisation temporaire d'utilisation)
- c. Les préparations magistrales, hospitalières et officinales
- d. Les plantes médicinales
- e. Les produits sanguins labiles

14. L'imputabilité intrinsèque

- a. Est la combinaison d'une évaluation des critères chronologiques et bibliographiques
- b. Doit être établie de manière indépendante pour chaque médicament
- c. Est influencée par le degré d'imputabilité des médicaments associés
- d. Est la combinaison d'une évaluation des critères chronologiques et sémiologiques
- e. Est la combinaison d'une évaluation des critères sémiologiques et bibliographiques

15. Qui peut déclarer la survenue d'un effet indésirable lié à un médicament ?

- a. Les médecins
- b. Les pharmaciens
- c. Les infirmiers
- d. Les patients
- e. Les directeurs administratifs des établissements de santé

16. Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles favorisent le passage des médicaments à travers la barrière foeto-placentaire :

- a. Un poids moléculaire supérieur à 600 D
- b. Un poids moléculaire inférieur à 600 D
- c. Une forte liposolubilité
- d. Une forte hydrosolubilité
- e. Une liaison protéique faible

17. Les trois groupes des antibiotiques qui peuvent être utilisés chez la femme enceinte sont les :

- a. Beta-lactamines
- b. Macrolides
- c. Polypeptides
- d. Tétracyclines
- e. Quinolones

18. Les risques liés à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez la femme enceinte sont :

- a. Risque tératogène
- b. Risque lié à la fermeture prématurée du canal artériel chez le fœtus
- c. Risque de développer une oligo-anurie fœtale
- d. Risque de développer une insuffisance rénale chez le fœtus
- e. Risque de développer une insuffisance cardiaque chez le fœtus

19. Concernant un médicament éliminé par voie rénale, quelle(s) proposition(s) est/sont juste(s)

- a. Sa toxicité augmente si un médicament associé réduit sa clairance hépatique
- b. Le pH urinaire influence sa filtration glomérulaire
- c. Son association à un médicament néphrotoxique augmente le risque iatrogène
- d. Le rein n'est pas le siège concerné par les interactions médicamenteuses
- e. Aucune des propositions n'est juste

20. Concernant les interactions médicamenteuses (IAM), quelle(s) proposition(s) est/sont juste(s) ?

- a. Les AVK peuvent subir des interactions en phase de distribution
- b. Les IAM par inhibition enzymatique sont évitables par un écart de 2h entre les prises
- c. Le niveau contre-indication est destinée à attirer l'attention du prescripteur
- d. Une IAM d'ordre pharmacocinétique modifie les effets du médicament
- e. Aucune des propositions n'est juste

21. Quelle(s) proposition(s) est/sont juste(s) ?

- a. Les interactions médicamenteuses par inhibition enzymatique sont gérables.
- b. L'inhibition enzymatique est un phénomène retardé.
- c. L'induction enzymatique est un phénomène retardé.
- d. Le métabolisme hépatique est le principal site impliqué dans les IAM d'ordre pharmacocinétiques
- e. Aucune des propositions n'est juste

22. La biodisponibilité d'un médicament renseigne sur :

- a. La quantité absorbée
- b. La vitesse d'absorption
- c. La voie d'absorption
- d. Le temps de disparition
- e. La quantité administrée

23. Un coefficient d'extraction égal à zéro pour un organe implique que :

- a. Le médicament ne peut pas passer à travers l'organe
- b. L'organe ne participe pas l'élimination du médicament
- c. L'élimination ne dépend que du débit de perfusion de l'organe
- d. La clairance de l'organe est nulle
- e. La clairance totale est nulle

24. la constante d'élimination K_e est :

- a. Propositionnelle au $T_{1/2}$
- b. Est inversement propositionnelle au $T_{1/2}$
- c. Ne dépend pas du $T_{1/2}$
- d. Est proportionnelle à la clairance
- e. Est inversement proportionnelle à la clairance

25. La Ciprofloxacine.

- a. Agit sur l'ADN gyrase
- b. Agit sur le ribosome bactérien
- c. Peut être utilisé en sécurité chez la femme enceinte
- d. Est inefficace sur un germe intracellulaire
- e. Possède un effet post antibiotique

26. Gentamicine.

- a. Agit sur la paroi bactérienne
- b. Agit sur le ribosome bactérien
- c. Peut être utilisé en sécurité chez la femme enceinte
- d. Possède une bonne absorption orale
- e. Possède un effet néphrotoxique

27. Doxycycline

- a. Agit sur la paroi bactérienne
- b. Agit sur le ribosome bactérien
- c. Peut être utilisé en sécurité chez la femme enceinte
- d. Possède une bonne absorption orale
- e. Possède une indication dans l'acné

28. Parmi les voies d'administration suivantes, laquelle (lesquelles) évite(ent) complètement l'effet de premier passage hépatique ?

- a. La voie orale
- b. La voie sublinguale
- c. La voie rectale
- d. La voie intra-veineuse
- e. La voie intra-musculaire

29. Quels sont les principaux mécanismes de résorption des médicaments administrés par voie orale ?

- a. La filtration glomérulaire
- b. La diffusion passive à travers les bicouches lipidiques
- c. L'endocytose
- d. Le passage actif à travers des transporteurs membranaires
- e. Le transport facilité via des protéines membranaires

30. Si un médicament a un volume de distribution très élevé, cela signifie :

- a. Qu'il reste majoritairement dans le sang
- b. Qu'il est excrété rapidement
- c. Qu'il diffuse largement dans les tissus
- d. Qu'il n'est pas absorbé
- e. Qu'il est fortement lié à l'albumine

31. En Algérie, qui est légalement autorisé à prescrire des médicaments :

- a. Les médecins
- b. Les pharmaciens
- c. Les sages-femmes (certains médicaments)
- d. Les dentistes
- e. Les kinésithérapeutes

32. Quel élément n'est pas obligatoire sur une ordonnance :

- a. L'âge du patient
- b. La posologie
- c. La signature du médecin
- d. La durée du traitement
- e. Le numéro de sécurité sociale du patient

33. Concernant la prescription des stupéfiants :

- a. Elle se fait sur une ordonnance classique
- b. La durée maximale de prescription est de 28 jours
- c. La posologie doit être indiquée en toutes lettres visibles
- d. Elle peut concerner des substances stupéfiantes non contenues dans une spécialité Pharmaceutique ou une préparation magistrale.
- e. Peut concerner des molécules comme la morphine.

34. l'activation du récepteur 5-HT₄ (de la sérotonine) couplé à la protéine G_s entraîne :

- a. l'inhibition de l'adényl-cyclase
- b. l'activation de la PLC d'où l'augmentation de l'IP₃ et le DAG
- c. l'ouverture des canaux potassique avec hyperpolarisation
- d. la stimulation de l'adényl-cyclase et l'augmentation de l'AMPc
- e. L'inhibition des canaux calciques voltage-dépendants

35. le salbutamol (Ventoline®), agit comme agoniste des récepteurs β_2 - adrénergiques dans le traitement de l'asthme. Quel est son mécanisme d'interaction avec sa cible ?

- a. Activation de la protéine G_s, augmentation de l'ampc, relâchement des muscles lisses bronchiques
- b. Inhibition de la protéine G_i, diminution de l'ampc, contraction du muscle lisse
- c. Activation de la phospho-lipase c (plc) et augmentation du calcium intracellulaire
- d. Ouverture directe des canaux potassique, hyperpolarisation
- e. Blocage des canaux calciques voltage-dépendants

36. Quels effets sont associés à la phényléphrine ?

- a. Bradycardie réflexe
- b. Bronchodilatation
- c. Vasoconstriction au sein de la muqueuse nasale
- d. Hypoglycémie
- e. Mydriase

37. Un patient arrive aux urgences en choc anaphylactique. Quels sympathomimétiques sont adaptés ?

- a. Méthylergométrine
- b. Noradrénaline
- c. Salbutamol
- d. Adrénaline
- e. Terbutaline

38. Dans les essais cliniques

- a. La dose maximale tolérée est évaluée au cours de la phase II
- b. La dose optimale dans l'étude pilote
- c. L'évaluation du rapport bénéfice/risque est évalué dans l'étude pivot
- d. Les modalités d'arrêt de traitement sont déterminées dans la phase I
- e. Utilisent toujours des volontaires malades

39. La stimulation des récepteurs β -adrénergiques conduit aux effets physiologiques suivants :

- a. effet inotrope positif
- b. Vasodilatation et bronchoconstriction
- c. augmentation de la sécrétion de rénine
- d. Diminution de la sécrétion d'insuline
- e. stimulation de la lipolyse

40. Effets indésirables des AINS:

- a. Faible effet allergisant
- b. Gastralgies
- c. Hémorragie digestive
- d. Racourcissement du tps de saignement
- e. Salicylisme: acouphènes, vertiges, ↓ audition

UNIVERSITE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE EMEDECINE

EXAMEN UNITE D'ENSEIGNEMENT DE PHARMACOLOGIE

Veillez cochez la ou les propositions justes durée 1H : 15

1. Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes :

- ☒ a. Le foie est le principal organe du métabolisme des médicaments
- b. Tous les médicaments sont inactifs avant d'être métabolisés
- ☒ c. Les métabolites des médicaments peuvent parfois être toxiques
- d. La première phase du métabolisme hépatique implique principalement des réactions de conjugaisons
- ☒ e. Le métabolisme a pour principal objectif de rendre le médicament plus hydrosoluble pour faciliter son élimination

2. Au sujet de l'induction enzymatique :

- ☒ a. Elle augmente l'activité des enzymes de métabolisation
- b. N'a aucun impact sur les interactions médicamenteuses
- c. N'a pas d'impact sur l'effet thérapeutique
- ☒ d. Le tabac est un inducteur enzymatique
- e. L'oméprazole est un inducteur enzymatique

3. Concernant l'élimination des médicaments :

- ☒ a. La sécrétion tubulaire des médicaments est un phénomène actif qui utilise des transporteurs
- ☒ b. Les substances transportées par un même système peuvent entrer en compétition
- c. L'alcalinisation des urines favorise l'élimination des bases faibles
- d. L'insuffisance rénale n'a pas d'impact sur l'élimination des médicaments
- e. Le cycle entérohépatique raccourcit la durée d'activité des médicaments

4. Concernant les médicaments du système parasympathique :

- a. L'atropine est indiquée dans la maladie d'alzheimer
- b. La nicotine est indiquée dans le traitement du glaucome
- ☒ c. La néostigmine est indiquée dans le traitement de la myasthénie
- ☒ d. La scopolamine est indiquée comme antinauséeux dans le mal des transports
- ☒ e. L'ipratropium est indiqué comme bronchodilatateur dans le traitement de l'asthme

5. Les parasympatholytiques de synthèse peuvent être utilisés dans le traitement de :

- a. La constipation
- ☒ b. La maladie de parkinson
- c. La dépression
- d. L'anxiété
- ☒ e. L'asthme

6. Les acétylcholinestérasiques agissent par :

- a. Blocage du récepteur muscarinique de l'acétylcholine
- b. Blocage du récepteur nicotinique de l'acétylcholine
- ☒ c. Inhibition de l'acétylcholinestérase
- d. Augmentation de la libération de l'acétylcholine
- ☒ e. Diminution de la dégradation de l'acétylcholine

7. Concernant les myorelaxants :

- a. Agissent sur le récepteur muscarinique de l'acétylcholine
- ☒ b. Les benzodiazépines sont des myorelaxants à action centrale
- c. Les doses myorelaxantes des benzodiazépines sont moins élevées que les doses anxiolytiques
- d. Le baclofène est indiqué dans les blépharospasmes
- ☒ e. Le dantrolène est utilisé en cas d'hyperthermie maligne et dans le syndrome malin des neuroleptiques.

8. Lesquels des médicaments suivants sont des curarisants non dépolarisants :

- a. Succinylcholine
- ☒ b. Pancuronium
- ☒ c. Tubocurarine
- d. L'Acétylcholine
- e. Diazépam

9. Les curares entraînent :

- a. Une paralysie dans l'ordre des gros muscles, puis des petits muscles
- b. Une perte de la conscience
- c. Une hypertension
- ☒ d. Une augmentation de la pression intragastrique via la succinylcholine
- ☒ e. Des fasciculations transitoires au niveau du thorax et de l'abdomen via la succinylcholine

10. Un effet indésirable est :

- a. Une réaction nocive, voulue, qui se produit uniquement en cas de surdosage
- b. Une réaction nocive, voulue, qui se produit aux posologies thérapeutiques
- ☒ c. Une réaction nocive, non voulue, qui se produit aux posologies thérapeutiques
- ☒ d. Observé en cas d'une utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament
- ☒ e. Une réaction liée à l'utilisation d'un médicament défectueux ou de mauvaise qualité

11. Les effets indésirables médicamenteux de type A

- ☒ a. Sont directement liés à l'effet principal du médicament
- b. Sont uniquement d'ordre pharmacocinétique
- ☒ c. Sont assez fréquents, et connus dès les essais cliniques
- d. Peuvent être d'origine immunologique
- e. Se produisent suite à une prise chronique du médicament

12. Les caractéristiques des réactions pseudo-allergiques sont les suivantes

- a. Réaction immuno-allergique
- ☒ b. Réaction non immuno-allergique
- c. Nécessite la liaison antigène-anticorps
- ☒ d. Sont dues à la libération directe d'histamine secondaire à la dégranulation des basophiles
- e. Elles nécessitent une sensibilisation préalable

13. Les éléments à déclarer dans un système de pharmacovigilance liés aux médicaments sont :

- ☒ a. Les molécules d'homéopathie
- ☒ b. Les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une ATU (autorisation temporaire d'utilisation)
- ☒ c. Les préparations magistrales, hospitalières et officinales
- d. Les plantes médicinales
- e. Les produits sanguins labiles

14. L'imputabilité intrinsèque

- a. Est la combinaison d'une évaluation des critères chronologiques et bibliographiques
- ☒ b. Doit être établie de manière indépendante pour chaque médicament
- c. Est influencée par le degré d'imputabilité des médicaments associés
- ☒ d. Est la combinaison d'une évaluation des critères chronologiques et sémiologiques
- e. Est la combinaison d'une évaluation des critères sémiologiques et bibliographiques

15. Qui peut déclarer la survenue d'un effet indésirable lié à un médicament ?

- ☒ a. Les médecins
- ☒ b. Les pharmaciens
- ☒ c. Les infirmiers
- ☒ d. Les patients
- e. Les directeurs administratifs des établissements de santé

16. Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles favorisent le passage des médicaments à travers la barrière foeto-placentaire :

- a. Un poids moléculaire supérieur à 600 D
- ☒ b. Un poids moléculaire inférieur à 600 D
- ☒ c. Une forte liposolubilité
- d. Une forte hydrosolubilité
- ☒ e. Une liaison protéique faible

17. Les trois groupes d'antibiotiques qui peuvent être utilisés chez la femme enceinte sont les :

- ☒ a. Beta-lactamines
- ☒ b. Macrolides
- ☒ c. Polypeptides
- d. Tétracyclines
- e. Quinolones

18. Les risques liés à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez la femme enceinte sont :

- ☒ a. Risque tératogène
- ☒ b. Risque lié à la fermeture prématurée du canal artériel chez le fœtus
- ☒ c. Risque de développer une oligo-anurie fœtale
- ☒ d. Risque de développer une insuffisance rénale chez le fœtus
- ☒ e. Risque de développer une insuffisance cardiaque chez le fœtus

19. Concernant un médicament éliminé par voie rénale, quelle(s) proposition(s) est/sont juste(s)

- a. Sa toxicité augmente si un médicament associé réduit sa clairance hépatique
- b. Le pH urinaire influence sa filtration glomérulaire
- ☒ c. Son association à un médicament néphrotoxique augmente le risque iatrogène
- d. Le rein n'est pas le siège concerné par les interactions médicamenteuses
- e. Aucune des propositions n'est juste

20. Concernant les interactions médicamenteuses (IAM), quelle(s) proposition(s) est/sont juste(s) ?

- ☒ a. Les AVK peuvent subir des interactions en phase de distribution
- b. Les IAM par inhibition enzymatique sont évitables par un écart de 2h entre les prises
- c. Le niveau contre-indication est destinée à attirer l'attention du prescripteur
- d. Une IAM d'ordre pharmacocinétique modifie les effets du médicament
- e. Aucune des propositions n'est juste

21. Quelle(s) proposition(s) est/sont juste(s) ?

- ☒ a. Les interactions médicamenteuses par inhibition enzymatique sont gérables.
- b. L'inhibition enzymatique est un phénomène retardé.
- ☒ c. L'induction enzymatique est un phénomène retardé.
- ☒ d. Le métabolisme hépatique est le principal site impliqué dans les IAM d'ordre pharmacocinétiques
- e. Aucune des propositions n'est juste

22. La biodisponibilité d'un médicament renseigne sur :

- ☒ a. La quantité absorbée
- ☒ b. La vitesse d'absorption
- c. La voie d'absorption
- d. Le temps de disparition
- e. La quantité administrée

23. Un coefficient d'extraction égal à zéro pour un organe implique que :

- a. Le médicament ne peut pas passer à travers l'organe
- ☒ b. L'organe ne participe pas à l'élimination du médicament
- c. L'élimination ne dépend que du débit de perfusion de l'organe
- ☒ d. La clairance de l'organe est nulle
- e. La clairance totale est nulle

24. la constante d'élimination K_e est :

- a. Proportionnelle au $T_{1/2}$
- ☒ b. Est inversement proportionnelle au $T_{1/2}$
- c. Ne dépend pas du $T_{1/2}$
- ☒ d. Est proportionnelle à la clairance
- e. Est inversement proportionnelle à la clairance

25. La Ciprofloxacine.

- ☒ a. Agit sur l'ADN gyrase
- b. Agit sur le ribosome bactérien
- c. Peut être utilisé en sécurité chez la femme enceinte
- d. Est inefficace sur un germe intracellulaire
- e. Possède un effet post antibiotique

26. Gentamicine.

- a. Agit sur la paroi bactérienne
- ☒ b. Agit sur le ribosome bactérien
- c. Peut être utilisé en sécurité chez la femme enceinte
- d. Possède une bonne absorption orale
- ☒ e. Possède un effet néphrotoxique

27. Doxycycline

- a. Agit sur la paroi bactérienne
- ☒ b. Agit sur le ribosome bactérien
- c. Peut être utilisé en sécurité chez la femme enceinte
- ☒ d. Possède une bonne absorption orale
- ☒ e. Possède une indication dans l'acné

28. Parmi les voies d'administration suivantes, laquelle (lesquelles) évite(ent) complètement l'effet de premier passage hépatique ?

- a. La voie orale
- ☒ b. La voie sublinguale
- c. La voie rectale
- ☒ d. La voie intra-veineuse
- ☒ e. La voie intra-musculaire

29. Quels sont les principaux mécanismes de résorption des médicaments administrés par voie orale ?

- a. La filtration glomérulaire
- ☒ b. La diffusion passive à travers les bicouches lipidiques
- c. L'endocytose
- ☒ d. Le passage actif à travers des transporteurs membranaires
- e. Le transport facilité via des protéines membranaires

30. Si un médicament a un volume de distribution très élevé, cela signifie :

- a. Qu'il reste majoritairement dans le sang
- b. Qu'il est excrété rapidement
- ☒ c. Qu'il diffuse largement dans les tissus
- d. Qu'il n'est pas absorbé
- e. Qu'il est fortement lié à l'albumine

31. En Algérie, qui est légalement autorisé à prescrire des médicaments :

- ☒ a. Les médecins
- b. Les pharmaciens
- ☒ c. Les sages-femmes (certains médicaments)
- ☒ d. Les dentistes
- e. Les kinésithérapeutes

32. Quel élément n'est pas obligatoire sur une ordonnance :

- a. L'âge du patient
- b. La posologie
- c. La signature du médecin
- d. La durée du traitement
- ☒ e. Le numéro de sécurité sociale du patient

33. Concernant la prescription des stupéfiants :

- a. Elle se fait sur une ordonnance classique
- ☒ b. La durée maximale de prescription est de 28 jours
- ☒ c. La posologie doit être indiquée en toutes lettres visibles
- d. Elle peut concerner des substances stupéfiantes non contenues dans une spécialité Pharmaceutique ou une préparation magistrale.
- ☒ e. Peut concerner des molécules comme la morphine.

34. L'activation du récepteur 5-HT₄ (de la sérotonine) couplé à la protéine G_s entraîne :

- a. L'inhibition de l'adényl-cyclase
- b. L'activation de la PLC d'où l'augmentation de l'IP₃ et le DAG
- c. L'ouverture des canaux potassique avec hyperpolarisation
- ☒ d. la stimulation de l'adényl-cyclase et l'augmentation de l'AMPc
- e. L'inhibition des canaux calciques voltage-dépendants

35. le salbutamol (Ventoline®), agit comme agoniste des récepteurs β_2 - adrénergiques dans le traitement de l'asthme. Quel est son mécanisme d'interaction avec sa cible ?

- ☒ a. Activation de la protéine G_s, augmentation de l'ampc, relâchement des muscles lisses bronchiques
- b. Inhibition de la protéine G_i, diminution de l'ampc, contraction du muscle lisse
- c. Activation de la phospho-lipase c (plc) et augmentation du calcium intracellulaire
- d. Ouverture directe des canaux potassique, hyperpolarisation
- e. Blocage des canaux calciques voltage-dépendants

36. Quels effets sont associés à la phényléphrine ?

- ☒ a. Bradycardie réflexe
- b. Bronchodilatation
- ☒ c. Vasoconstriction au sein de la muqueuse nasale
- d. Hypoglycémie
- ☒ e. Mydriase

37. Un patient arrive aux urgences en choc anaphylactique. Quels sympathomimétiques sont adaptés ?

- a. Méthylérgométrine
- ☒ b. Noradrénaline
- c. Salbutamol
- ☒ d. Adrénaline
- e. Terbutaline

38. Dans les essais cliniques

- a. La dose maximale tolérée est évaluée au cours de la phase II
- ☒ b. La dose optimale dans l'étude pilote
- ☒ c. L'évaluation du rapport bénéfice/risque est évalué dans l'étude pivot
- d. Les modalités d'arrêt de traitement sont déterminées dans la phase I
- e. Utilisent toujours des volontaires malades

39. La stimulation des récepteurs β -adrénergiques conduit aux effets physiologiques suivants :

- ☒ a. effet inotrope positif
- b. Vasodilatation et bronchoconstriction
- ☒ c. augmentation de la sécrétion de rénine
- d. Diminution de la sécrétion d'insuline
- ☒ e. stimulation de la lipolyse

40. Effets indésirables des AINS:

- a. Faible effet allergisant
- ☒ b. Gastralgies
- ☒ c. Hémorragie digestive
- d. Racourcissement du tps de saignement
- ☒ e. Salicylisme: acouphènes, vertiges, ↓ audition

Dr Amine A. JADI
responsable du module

